

MODEL PERUBAHAN PERILAKU ABC (ANTECEDENTS, BEHAVIOUR AND CONSEQUENCES) UPAYA KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2

Supriadi
Kuslan Sunandar



**MODEL PERUBAHAN PERILAKU
ABC (*ANTECEDENTS, BEHAVIOUR
AND CONSEQUENCES*):
UPAYA KEPERAWATAN DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN
KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2**

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom.

Kuslan Sunandar, SKM, M.Kep, Sp.Kom.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Model Perubahan Perilaku ABC (*Antecedents, Behaviour and Consequences*): Upaya Keperawatan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe 2

Penulis: Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom.
Kuslan Sunandar, SKM, M.Kep, Sp.Kom.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-00-9

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga buku monograf dapat di selesaikan. Buku Monograf ini berjudul **Model Perubahan Perilaku ABC (Antecedents, Behaviour and Consequences): Upaya Keperawatan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe 2.**

International Diabetes Federation (IDF), mengungkapkan bahwa orang dewasa, berusia 20 hingga 79 tahun, satu dari sepuluh orang di seluruh dunia menderita diabetes, dan setiap lima detik, menyebabkan satu orang meninggal. Indonesia berada di urutan kelima dengan prevalensi 10,6% dari total penduduk, menderita diabetes melitus. Kondisi tersebut harus ditangani secara komprehensif, sehingga klien Diabetes Melitus Tipe 2 tetap dapat menjalani kehidupan dengan berkualitas. Salah satunya dengan melakukan tatakelola diet, aktifitas fisik dan pengobatan secara patuh.

Buku monograf ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu dalam upaya meningkatkan kepatuhan klien dalam tatakelola Diabetes Melitus Tipe 2 melalui perubahan perilaku ABC (Antecedents Behaviour and Consequences), meliputi tatakelola diet, tatkelola aktifitas fisik dan tatakelola obat. Selain itu buku monograf ini dapat menjadi bahan acuan para mahasiswa, dosen dan praktisi dalam menerapkan asuhan keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan klien Diabetes Melitus Tipe 2.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak hingga buku monograf ini selesai. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku monograf ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Nopember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 KONSEP PENDIDIKAN KESEHATAN 5

A. Pengertian Pendidikan Kesehatan.....	5
B. Tujuan Pendidikan Kesehatan.....	7
C. Lingkup Pendidikan Kesehatan	8
D. Ranah Perilaku terkait Pendidikan Kesehatan.....	9
E. Pendidikan Kesehatan terkait Tingkat Pencegahan.....	11

BAB 3 TERAPI PERILAKU ABC SEBAGAI PENDEKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2..... 15

A. Pengertian Perilaku ABC	15
B. <i>Antecedent</i> Klien Diabetes Melitus Tipe 2.....	16
C. <i>Behavior</i> Klien Diabetes Melitus Tipe 2.....	21
D. <i>Consequences</i> Klien Diabetes Melitus Tipe 2	24

BAB 4 KONSEP DIABETES MELITUS DAN TATALAKSANA DIABETES MELLITUS TIPE 2 27

A. Konsep Diabetes Melitus	27
B. Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2.....	35

BAB 5 KEPATUHAN KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2

.....	47
A. Pengertian Kepatuhan	47
B. Manfaat Perilaku Patuh	47
C. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dan Ketidak patuhan	49
D. Pengukuran Kepatuhan.....	52

BAB 6 PENUTUP57

DAFTAR PUSTAKA.....61

GLOSARIUM65

PROFIL PENULIS67

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi perhatian di bidang kesehatan, menarik perhatian nasional, regional dan global. Dengan merebaknya masalah PTM, Indonesia memiliki tiga beban masalah kesehatan yaitu *re-emerging diseases*, *emerging diseases* dan prevalensi PTM. Penyakit tidak menular sendiri berarti penyakit kronis yang tidak menular dari orang ke orang. Cara hidup modern telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan makan, merokok dan konsumsi alkohol, yang meningkatkan terjadinya penyakit degeneratif (penyakit akibat kemunduran fungsi organ). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pengobatan Penyakit Menular (PTM) yang mengacu pada *International Classification of Diseases* (klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait), PTM diklasifikasikan menjadi 12 jenis penyakit termasuk endokrin, gizi - dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus (Kemenkes RI, 2022)

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kegagalan sekresi insulin, penurunan sekresi insulin, atau resistensi insulin (*American Diabetes Association*, 2018). Menurut *International Diabetes Federation* (IDF), pada tahun 2021, 537 juta orang dewasa (berusia 20 hingga 79 tahun) atau satu dari sepuluh orang di seluruh dunia akan menderita diabetes, dan juga akan menyebabkan 6,7 juta kematian, atau satu orang setiap lima detik. Indonesia berada di urutan kelima dengan total 19,47 juta penderita diabetes.

Prevalensi diabetes di Indonesia dengan jumlah penduduk 179,72 juta adalah 10,6% (Pusdatin Kemenkes, 2020)

Diabetes merupakan masalah kesehatan yang sangat terlihat di Indonesia, sebagai salah satu penyebab kematian serta DM juga dapat menimbulkan komplikasi, sehingga penatalaksanaan Diabetes Melitus yang tepat diperlukan untuk mengurangi kejadian dan/atau resiko kematian dan komplikasi yang tidak diinginkan. Target klien Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pasien diabetes ditetapkan 100%, yang dilakukan di seluruh tingkat pelayanan, termasuk di komunitas. Program penanggulangan Diabetes Melitus komunitas dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh penderita diabetes, minimal sebulan sekali dilaksanakan pemeriksaan gula darah, perubahan gaya hidup dan penyuluhan gizi serta rujukan bila diperlukan. Beberapa penelitian berpendapat bahwa peningkatan kasus Diabetes Melitus dan komplikasinya disebabkan oleh ketidakpatuhan klien Diabetes Melitus dalam menjalani terapi. Mengobati Diabetes Melitus dimulai dengan pola hidup sehat. Kepatuhan Diabetes Melitus mengelola perilaku klien dalam terapi nutrisi, terapi aktivitas (pelatihan fisik) dan terapi farmakologis/obat. (Perhimpunan Endokrinologi Indonesia, 2021).

Kepatuhan adalah salah satu penentu yang paling penting dari keberhasilan pengobatan untuk pasien dengan diabetes, dan ketidakpatuhan berkontribusi terhadap hasil klinis yang buruk, risiko komplikasi dan kualitas hidup yang buruk. Kepatuhan merupakan masalah yang perlu diperhatikan pada pasien Diabetes Melitus tipe 2. Beberapa penelitian telah melaporkan rendahnya kepatuhan pada klien Diabetes Melitus. Menurut hasil penelitian Firdiawani (2020), kepatuhan klien Diabetes Melitus rendah (57%). Begitu pula dengan hasil

penelitian Ernawati et al (2020), hanya 46,88% klien Diabetes Melitus yang patuh.

Terapi kepatuhan sangat penting untuk klien diabetes melitus tipe 2, karena beberapa alasan berikut: 1) Kepatuhan terhadap terapi (baik obat-obatan maupun perubahan gaya hidup) membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti kerusakan ginjal, kebutaan, atau gangguan saraf. 2) Kepatuhan klien Diabetes Melitus dapat menurunkan risiko, dengan mengontrol faktor-faktor seperti tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah, 3) Kepatuhan dapat meningkatkan kualitas hidup klien dapat lebih energik, 4) Kepatuhan akan mengurangi biaya perawatan, karena risiko komplikasi Diabetes Melitus dapat dikurangi. Diantara terapi untuk meningkatkan kepatuhan klien Diabetes Melitus Tipe 2 adalah melalui terapi perilaku ABC (*antecedents, behaviour and consequences*).

BAB 2

KONSEP PENDIDIKAN KESEHATAN

A. Pengertian Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu atau kelompok dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Beberapa ahli mengemukakan tentang pendidikan Kesehatan, diantaranya Green & Kreuter (2005) mengemukakan bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi dari proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat, sedangkan menurut Nutbeam (1998). pendidikan kesehatan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. WHO (*World Health Organization*, 1986) juga mengemukakan, pendidikan kesehatan adalah proses yang mengajak individu untuk mempelajari tentang kesehatan dan cara menjaga serta meningkatkan kesehatannya.

Kriswanto (2012) menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses yang membantu individu, baik secara mandiri maupun kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka dan orang lain. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatannya, tidak hanya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik, tetapi juga dengan

memperbaiki lingkungan, baik fisik maupun non-fisik untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dengan penuh kesadaran. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku hidup sehat yang didasari atas kesadaran diri baik itu di dalam individu, kelompok maupun masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Secara konseptual, pendidikan kesehatan merupakan upaya untuk memengaruhi atau mengajak individu, kelompok, dan masyarakat agar berperilaku hidup sehat. Secara operasional, pendidikan kesehatan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, serta praktik masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. (Notoatmodjo, 2014).

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan mereka. Pendidikan kesehatan mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan manusia yang sehat, mengingat kesehatan merupakan dambaan setiap manusia, karena manusia yang sehat, yang dapat melakukan aktivitasnya dengan optimal. Dalam keperawatan komunitas pendidikan kesehatan menjadi strategi penting yang dilakukan dalam segala situasi dan masalah di masyarakat.

B. Tujuan Pendidikan Kesehatan

Tujuan pendidikan kesehatan telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya, Pender (1987) menyatakan bahwa tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas melalui pengembangan perilaku sehat, Beauchamp (1995) menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar individu dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan. Green dan Kreuter (2005) menyebutkan tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku individu dan komunitas agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, sedangkan menurut Simons-Morton dan Greene (1996), pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan individu dalam merespons isu-isu kesehatan dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, serta pernyataan dari WHO (1986), yang menekankan bahwa tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang bijak.

Setiap ahli memberikan perspektif yang sedikit berbeda, tetapi semua menekankan pentingnya perubahan perilaku untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Perubahan perilaku menjadi fokus utama dalam pendidikan kesehatan. F. Skinner (1938) seorang psikolog Amerika yang dikenal dengan teori behaviorisme, menjelaskan perilaku sebagai respons yang dipelajari terkait faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Respons yang dimaksud adalah pengetahuan, sikap dan tindakan (*psikomotor*), sehingga tujuan dari

pendidikan kesehatan, meliputi ketiga ranah perilaku tersebut.

C. Lingkup Pendidikan Kesehatan

1. Berdasarkan Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan cara individu atau kelompok memandang dan mengelola kesehatan mereka. Pendidikan kesehatan mengarahkan terhadap perubahan perilaku kesehatan tersebut, seperti halnya yang diungkapkan oleh McLeroy et al. (1988), yakni:

a. Perilaku terhadap Sakit dan Penyakit

Perilaku ini berkaitan dengan pemahaman individu tentang apa itu sakit dan penyakit, meliputi bagaimana seseorang mengenali gejala, memahami penyebab penyakit, dan respon terhadap kondisi kesehatan mereka. Misalnya, seseorang yang memahami pentingnya deteksi dini akan lebih proaktif dalam mencari perawatan.

b. Perilaku terhadap Pelayanan Kesehatan

Perilaku ini mencakup bagaimana individu menggunakan layanan kesehatan, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, serta keterlibatan dalam proses pengobatan. Perilaku ini bisa dipengaruhi oleh pengetahuan tentang sistem kesehatan, pengalaman pribadi, dan norma sosial.

c. Perilaku terhadap Makanan dan Minuman

Perilaku ini berhubungan dengan pilihan makanan dan minuman yang dikonsumsi, yang memengaruhi kesehatan secara langsung. Pola makan yang sehat, pemilihan bahan makanan, serta kebiasaan makan

yang baik dapat mencegah berbagai penyakit. Kesadaran akan nutrisi dan dampak makanan pada kesehatan juga berperan besar dalam perilaku ini.

d. Perilaku terhadap Lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial mempengaruhi perilaku kesehatan. Faktor-faktor seperti sanitasi, polusi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat berdampak pada kesehatan individu. Selain itu, lingkungan sosial, termasuk dukungan keluarga dan komunitas, juga mempengaruhi keputusan kesehatan.

D. Ranah Perilaku terkait Pendidikan Kesehatan

Pendidikan Kesehatan bertujuan meningkatkan pemahaman individu tentang kesehatan, penyakit, dan praktik kesehatan yang baik. Hal ini mencakup informasi tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*).

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan (H. L Bloom, revisi Anderson, dkk, 2001), yaitu Mengingat (*remember*), Memahami (*understand*), Menerapkan (*aplication*), Menganalisis (*analyze*), dan Penilaian (*evaluate*), berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek berdasarkan kriteria atau standar yang ada, dan 6) Menciptakan (*create*).

1. Mengingat (*Remember*)

Tingkat dasar ini mencakup kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contoh aktivitasnya meliputi menghafal fakta, definisi,

dan konsep tentang suatu penyakit yang ada di masyarakat.

2. Memahami (*Understand*)

Pada tingkat ini, individu dapat menjelaskan makna informasi dan memahami konsep dengan baik. Contoh aktivitasnya adalah merangkum, menginterpretasi, atau menjelaskan ide-ide.

3. Menerapkan (*Apply*)

Di tingkat ini, individu menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau dalam konteks yang berbeda. Contoh aktivitasnya adalah memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuannya dalam praktik.

4. Menganalisis (*Analyze*)

Pada tingkat ini melibatkan kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami bagaimana bagian tersebut saling berhubungan. Contoh aktivitasnya termasuk mengidentifikasi pola, membandingkan, dan mengklasifikasikan.

5. Menilai (*Evaluate*)

Di tingkat ini, individu dapat membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Aktivitas ini meliputi menilai argumen, mendebat, dan memberikan rekomendasi.

6. Menciptakan (*Create*)

Pada tingkat tertinggi ini melibatkan kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen berbeda untuk membentuk sesuatu yang baru. Ini mencakup merancang, menghasilkan, atau mengembangkan ide dan produk baru.

E. Pendidikan Kesehatan terkait Tingkat Pencegahan

Pendidikan kesehatan berkaitan dengan tingkat pelayanan kesehatan dengan mengarahkan pada upaya pencegahan (Notoatmodjo, 2014). Tingkat pencegahan menurut Leavell and Clark (1965) dan pengembangannya oleh Beoglehole (1993) merujuk pada pendekatan perjalanan penyakit, membagi pencegahan menjadi beberapa level atau tingkatan, seperti yang digambarkan di bawah.

1. Pencegahan Promordial (*primordial prevention*)

Pencegahan Promordial (*primordial prevention*) merupakan pencegahan tingkat dasar, adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko atau menjaga agar tingkat risiko penyakit tetap rendah dalam masyarakat secara umum. Tujuan dari pencegahan primordial ini adalah untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial-ekonomi dan budaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit. Upaya ini terutama relevan untuk mengatasi masalah penyakit tidak menular yang semakin meningkat saat ini.

Pencegahan ini mencakup usaha untuk memelihara dan mempertahankan kebiasaan hidup sehat yang sudah ada dalam masyarakat, yang dapat mencegah peningkatan risiko terhadap berbagai penyakit. Contohnya menjaga pola makan yang sehat, kebiasaan berolahraga, dan praktik sehat lainnya untuk mempertahankan tingkat risiko yang rendah terhadap penyakit.

2. Pencegahan Primer (*primary prevention*)

Pencegahan tingkat pertama adalah upaya untuk mencegah penyakit dengan mengatasi atau mengontrol faktor-faktor risiko, dengan sasaran utama orang sehat. Ini dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan secara

umum (promosi kesehatan) serta upaya pencegahan khusus terhadap penyakit tertentu. Tujuan pencegahan tingkat pertama adalah mencegah terjadinya penyakit dengan mengendalikan agen dan faktor determinan. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit sebelum faktor risiko muncul, seperti vaksinasi dan promosi gaya hidup sehat.

3. Pencegahan Sekunder (scondary prevention)

Pencegahan skunder adalah upaya untuk mencegah komplikasi atau kekambuhan suatu penyakit setelah diagnosis awal. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit lebih awal dan mengurangi dampak negatifnya. Contoh dari pencegahan skunder termasuk skrining rutin untuk kanker, pengelolaan faktor risiko pada pasien dengan penyakit jantung, atau terapi pemeliharaan setelah pengobatan infeksi. Dengan melakukan pencegahan skunder, kita dapat meningkatkan prognosis pasien dan kualitas hidup mereka. Usaha pencegahan penyakit Tingkat kedua secara garis besarnya dapat dibagi dalam diagnosa dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) serta pembatasan cacat (*disability limitation*).

4. Pencegahan Tersier (tertiery prevention)

Pencegahan tertier adalah tahap dalam pencegahan penyakit yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan komplikasi dari penyakit yang sudah ada. Ini biasanya melibatkan perawatan dan rehabilitasi untuk membantu individu memulihkan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, pencegahan tertier berfokus pada meningkatkan kualitas hidup pasien dan meminimalkan efek negatif dari penyakit yang sudah ada. Contoh tindakan pencegahan tertier termasuk: 1)

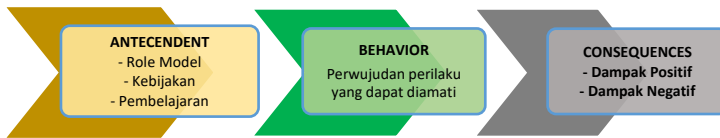
Pengelolaan Penyakit, mengontrol gejala dan mencegah kemunduran lebih lanjut, seperti dalam kasus diabetes atau penyakit jantung, 2) Rehabilitasi, program rehabilitasi fisik atau psikologis untuk membantu pasien pulih setelah sakit atau operasi, dan 3) Dukungan Psikososial, memberikan dukungan emosional dan sosial untuk membantu klien beradaptasi dengan kondisi mereka.

BAB 3

TERAPI PERILAKU ABC SEBAGAI PENDEKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2

A. Pengertian Perilaku ABC

Perilaku ABC merupakan gabungan dari tiga unsur, yaitu: *antecedents*, *behaviour and consequences* (ABC). Model ABC menjelaskan bahwa perilaku sebenarnya dapat diubah dengan dua cara, yaitu dengan mempengaruhi perilaku sebelum terjadi dan dengan mempengaruhi perilaku sesudahnya (*exacting*). Jika kita mencoba untuk mempengaruhi perilaku sebelum itu terjadi, kita telah menggunakan *antecedens*. Karena kita mencoba mempengaruhi perilaku dengan melakukan sesuatu setelah perilaku itu terjadi, kita menggunakan konsekuensi. Jadi, anteseden mendorong terbentuknya tingkah laku (*behavior*) yang diikuti dengan akibat. Memahami ketiga elemen yang saling berinteraksi ini sangat berguna bagi manajer untuk menganalisis masalah kinerja, menentukan tindakan korektif, dan merancang lingkungan kerja dan sistem manajemen berkinerja tinggi (Mayer, 1977).



Gambar 3.1. Model Perilaku ABC
(*antecedents, behaviour and consequences*)

B. *Antecedent* Klien Diabetes Melitus Tipe 2

Antecedents dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, sesuatu, atau kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. *Antecedents* ini keberadaanya tidak dapat dikendalikan. Karakteristik utama dari *antecedents* adalah: selalu ada sebelum perilaku terbentuk, menyediakan informasi tertentu, selalu berpasangan dengan *consequences*, dan *antecedents* tanpa diikuti *consequences* mempunyai dampak jangka pendek. *Antecedents* pada Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 antara lain:

1. Obesitas atau kelebihan berat badan

Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan hingga mengganggu kesehatan. Obesitas diukur dengan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT), di mana seseorang dianggap obesitas jika IMT-nya lebih besar dari atau sama dengan 30 (WHO, 2020). Obesitas terjadi ketika kalori yang dikonsumsi melebihi kalori yang dibakar oleh tubuh dalam jangka waktu yang lama (CDC, 2022).

Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, dan beberapa jenis kanker. Obesitas memiliki banyak faktor penyebab, termasuk faktor genetik,

lingkungan, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik.

2. Penumpukan lemak pada perut,

Penumpukan lemak dalam perut, yang sering disebut sebagai lemak visceral, adalah jenis lemak yang terkumpul di sekitar organ-organ internal seperti hati, pankreas, dan usus. Lemak ini dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Beberapa sumber utama penumpukan lemak perut antara lain (*The Lancet*, 2020):

- a. Gaya hidup yang tidak aktif
Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan metabolisme dan peningkatan penumpukan lemak perut. Ini terkait dengan peningkatan risiko berbagai penyakit metabolik.
- b. Diet yang tidak sehat
Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan karbohidrat olahan dapat meningkatkan akumulasi lemak visceral. Diet tinggi kalori tanpa keseimbangan dengan pembakaran energi cenderung menyebabkan penumpukan lemak di perut.
- c. Faktor genetik
Faktor keturunan dapat berperan dalam kecenderungan seseorang untuk mengembangkan penumpukan lemak perut. Gen yang terkait dengan metabolisme lemak dapat mempengaruhi bagaimana tubuh menyimpan lemak.
- d. Hormon
Ketidakseimbangan hormon, seperti peningkatan kortisol (hormon stres), dapat berkontribusi pada akumulasi lemak visceral. Perubahan hormon selama

menopause juga dapat menyebabkan penumpukan lemak di daerah perut pada wanita.

e. Sedentari

Sedentari atau gaya hidup sedentari merujuk pada pola hidup yang kurang aktivitas fisik, di mana seseorang menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk atau berbaring, seperti menonton televisi, bekerja di depan komputer, atau menggunakan perangkat elektronik tanpa banyak bergerak. Gaya hidup sedentari sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan gangguan musculoskeletal (Tremblay, M. S., et al, 2020).

Gaya hidup sedentari sangat berisiko, terutama pada individu yang berusia lanjut, di mana kurangnya aktivitas fisik bisa memperburuk kondisi kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, penurunan massa otot, dan bahkan gangguan kognitif. (WHO, 2020)

f. Usia di atas 45 tahun

Di atas usia 45 tahun, risiko untuk terjadi Diabetes Melitus tipe 2 meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor fisiologis dan metabolik yang terkait dengan proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin, penurunan fungsi sel-sel pankreas, dan peningkatan resistensi insulin, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan Diabetes Melitus tipe 2 (*American Diabetes Association*, 2020).

Studi lainnya, seperti yang diterbitkan dalam jurnal *Diabetes Care* (2018), menunjukkan bahwa prevalensi diabetes tipe 2 meningkat secara signifikan pada orang

berusia 45 tahun ke atas, terutama pada mereka yang tidak menjaga pola makan dan tingkat aktivitas fisik yang sehat, sehingga pengelolaan faktor risiko tersebut sangat penting untuk mencegah onset diabetes tipe 2 di usia tersebut.

g. Riwayat keluarga

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan kondisi dimana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif (resistensi insulin) atau tidak memproduksi cukup insulin untuk menjaga kadar gula darah dalam rentang normal. Riwayat keluarga memainkan peran penting dalam risiko seseorang mengembangkan Diabetes Melitus Tipe 2. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hubungan antara Diabetes Melitus Tipe 2 dan riwayat keluarga (*National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases/NIDDK*. 2021).

1) Genetik

Jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung yang menderita Diabetes Melitus Tipe 2, risiko mereka untuk mengembangkan penyakit ini meningkat. Beberapa gen yang berperan dalam metabolisme gula darah dan sensitivitas insulin dapat diwariskan.

2) Faktor Risiko

Riwayat keluarga juga sering kali berkaitan dengan faktor risiko lain, seperti obesitas, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik, yang semuanya dapat meningkatkan kemungkinan terkena Diabetes Melitus Tipe 2.

3) Risiko Ganda

Jika kedua orang tua memiliki Diabetes Melitus Tipe 2, risiko seseorang untuk mengembangkan penyakit

ini bisa lebih tinggi dibandingkan jika hanya satu orang tua yang menderita.

h. Diet atau gizi tidak seimbang.

Diet yang tidak seimbang dan Diabetes Melitus Tipe 2 memiliki hubungan yang kuat, terutama dalam konteks faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini. Diet yang tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula, serta rendah serat, meningkatkan risiko Diabetes Melitus Tipe 2, hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa darah, penurunan sensitivitas insulin, dan resistensi insulin yang berkembang akibat pola makan tidak sehat (*American Diabetes Association, 2020*).

Pola makan yang kaya akan makanan olahan, lemak tinggi, dan rendah serat (seperti sayur dan buah) berhubungan dengan peningkatan risiko resistensi insulin, obesitas, serta gangguan metabolisme yang berujung pada terjadinya Diabetes Melitus Tipe 2. Di negara berkembang, pola makan yang buruk, peningkatan konsumsi makanan yang diproses tinggi lemak dan gula diikuti dengan penurunan konsumsi makanan bergizi alami seperti sayuran dan buah berkontribusi munculnya Diabetes Melitus Tipe 2. (WHO, 2020 & Lancet, 2017, *Diabetes Care*, 2020)

Antecedents ini mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi tidak menjamin bahwa output yang dihasilkan benar-benar bisa terjadi.

C. Behavior Klien Diabetes Melitus Tipe 2

Behaviour atau perilaku merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas. Teori motivasi menjelaskan bagaimana seseorang, yakni klien Diabetes Melitus Tipe 2 dapat dipengaruhi untuk bisa menyesuaikan diri pada perilaku yang baru. Dalam hal ini terjadi:

1. Proses penyesuaian diri

Setelah *antecedents* berhasil, selanjutnya masuk ke proses perilaku (*behaviour*) melalui proses penyesuaian diri terhadap perilaku baru yang akan dibentuk, atau akan terjadi. Proses Penyesuaian merupakan proses sepanjang hayat (*lifelong process*), dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat.

Menurut Sugeng Haryadi, dkk. proses penyesuaian diri dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses penyesuaian Diri

a. Dorongan keinginan

Pada awalnya individu di satu sisi memiliki dorongan keinginan untuk memperoleh arti atau makna (eksistensi) dalam kehidupannya, dan di sisi lain

individu mendapat peluang atau tuntutan dari luar dirinya sendiri.

b. Mempelajari

Mempelajari dengan memikirkan dan merasakan kondisi dan keadaan dirinya serta mempelajari peluang, tuntutan dan keterbatasan lingkungan hidupnya.

c. Pemahaman

Pemahaman tentang dirinya sendiri dan lingkungannya yang banyak tergantung pada persepsi dan kemampuan individu dalam belajar.

d. Interaksi

Menginteraksikan dorongan, kemampuan, dan persepsi dengan peluang, tuntutan dan keterbatasan lingkungan hidupnya secara dinamis.

e. Melakukan Tindakan

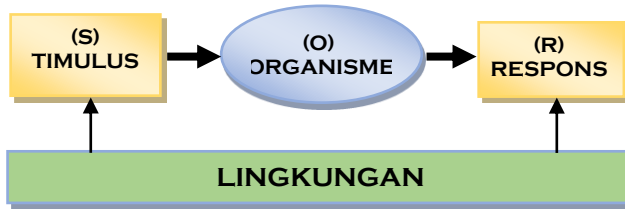
Upaya-upaya berupa suatu tindakan, dapat berupa tindakan positif atau negatif, aktif atau pasif, ataupun kombinasi antara keduanya.

2. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran tentang perilaku terjadi untuk menentukan mana yang sukses dan gagal. Belajar adalah kegiatan mental atau psikologis yang dilakukan seseorang sedemikian rupa sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang berbeda setelah belajar dan sebelum belajar. Belajar adalah proses mengubah perilaku individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaktif antara rangsangan dan tanggapan.

Teori behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Model Perubahan Perilaku ABC (Antecedents, Behaviour and Consequences): Upaya Keperawatan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe 2



Gambar 3. Mekanisme Perubahan

3. Upaya Membantu Klien Menyesuaikan Diri

Upaya yang harus dilakukan untuk membantu klien diabetes mellitus lebih mudah beradaptasi dengan perilaku baru, diantaranya:

- a. Diskusikan dengan klien, untuk tidak langsung berpersepsi bahwa lingkungan atau perilaku baru akan sulit. Semua berawal dari pikiran, dan ketika berfikir bahwa suatu hal itu sulit, memulainya pun akan terasa berat, begitupun sebaliknya.
- b. Bantu klien untuk mempersiapkan diri dan mental, melalui dukungan positif dari keluarga dan tenaga kesehatan.
- c. Hindari perbedaan dalam kecepatan setiap klien untuk menyesuaikan diri, dengan menghargai setiap perbedaan, termasuk dalam menjalankan perilaku baru.
- d. Siapkan waktu dan kesempatan pada klien untuk bertanya dan meminta bantuan, ketika klien mendapatkan kesulitan atau masalah. Interaksi akan membangun hubungan interpersonal yang baik.
- e. Perkuat lingkungan eksternal yang mampu menciptakan proses penyesuaian diri menuju perilaku baru, seperti keluarga dan teman sebaya klien Diabetes Melitus Tipe 2.

D. Consequences Klien Diabetes Melitus Tipe 2

Consequences adalah peristiwa yang mengikuti suatu perilaku dan mengubah kemungkinan bahwa perilaku itu akan diulangi di masa depan. *Consequences* mempengaruhi perilaku dengan dua cara, yaitu dengan memperkuat perilaku dan dengan mengurangi perilaku tertentu. Ada empat *consequences* perilaku: dua meningkatkan perilaku tertentu dan dua menurunkannya: 1) *consequences* yang memperkuat perilaku tertentu, yaitu penguatan positif, seperti mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan penguatan negatif, seperti meninggalkan atau sesuatu yang tidak kita inginkan. 2) *consequences* yang mengurangi perilaku tertentu, yaitu segala sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penalti, dan default, misalnya hilangnya kesempatan.

1. *Consequences* yang memperkuat perilaku

Consequences yang memperkuat perilaku tertentu, yakni:

- a. Penguatan positif
Seperti mendapatkan sesuatu yang di inginkan, yakni kepatuhan dalam diet, latihan aktivitas dan obat. Terhindar dari komplikasi.
- b. Penguatan negatif
Seperti meninggalkan sesuatu yang tidak di inginkan, yakni ketidakpatuhan dalam diet, latihan aktivitas dan obat, mengalami komplikasi atau bahkan kematian.

2. *Consequences* yang mengurangi perilaku

Consequences yang mengurangi perilaku tertentu, yakni:

- a. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan
Seperti munculnya komplikasi diabetes mellitus, seperti gangguan kardiovaskuler, gangguan ginjal, kerusakan saraf, kerusakan mata, gastropati diabetik,

disfungsi ereksi, masalah kulit, rentan terhadap infeksi, gangguan gigi, dan kaki diabetik.

b. *Default*

Seperti hilangnya kesempatan untuk memperbaiki segala yang dapat menjadikan penyakit diabetes mellitus tidak terkendali, komplikasi dan kematian.

BAB 4

KONSEP DIABETES MELITUS DAN TATALAKSANA DIABETES MELLITUS TIPE 2

A. Konsep Diabetes Melitus

1. Pengertian

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999)

2. Jenis

Berdasarkan penyebabnya, diabetes dibagi menjadi:

a. Diabetes melitus tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 disebabkan oleh kegagalan tubuh untuk memproduksi insulin. Diabetes tipe ini dapat terdeteksi ketika seseorang berusia muda.

b. Diabetes melitus tipe 2

Diabetes melitus tipe 2 disebabkan karena kekurangan insulin, dimana tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau insulin yang dihasilkan tidak dapat bekerja secara memadai. Hal ini

menyebabkan tubuh memiliki masalah dalam mengubah karbohidrat menjadi energi sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Diabetes tipe 2 merupakan jenis penyakit yang dapat menyerang orang dari segala usia, namun mayoritas terjadi pada orang berusia diatas 30 tahun.

c. Diabetes melitus gestasional

Wanita hamil yang tidak pernah menderita diabetes melitus sebelumnya tetapi ketika hamil memiliki kadar glukosa yang tinggi. Diabetes melitus gestasional terjadi karena adanya hormon kehamilan yang bekerja berlawanan dengan insulin. Diabetes melitus gestasional biasanya terjadi pada kehamilan trimester ke-2 atau ke-3 (setelah usia kehamilan 3 atau 6 bulan), dan umumnya menghilang sengan sendirinya setelah proses melahirkan.

3. Penyebab

Seseorang bisa dikatakan menderita diabetes mellitus karena beberapa penyebab, yaitu:

a. Tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur.

Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera ke pelayanan kesehatan. Kadang kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini.

b. Nutrisi yang tidak seimbang.

Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan

serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna.

c. Aktivitas fisik yang tidak seimbang.

Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat.

d. Mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan.

Kadar glukosa berlebih dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin.

e. Cemilan tidak sehat.

Apa yang dikonsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan, seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah seperti buah, sayur ataupun biji-bijian.

4. Tanda atau Gejala

Diabetes mellitus seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes mellitus. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain *poliuria* (sering buang air kecil), *polidipsia* (sering haus), dan *polifagia* (banyak makan/ mudah lapar). Selain itu sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota

tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu (pruritus), dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas.

a. Pada Diabetes Melitus Tipe 1

Gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah *poliuria*, *polidipsia*, *polifagia*, penurunan berat badan, cepat merasa lelah (*fatigue*), iritabilitas, dan *pruritus* (gatal-gatal pada kulit).

b. Pada Diabetes Melitus Tipe 2

Gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes Melitus Tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Klien Diabetes Melitus Tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf.

5. Menentukan Penyakit Diabetes Melitus

Untuk mengetahui apakah terkena diabetes mellitus atau tidak, dapat dilihat dari tes gula darah. Bukan hanya satu tes yang bisa dilakukan akan tetapi beberapa tes bisa menentukan tingkat gula dalam darah.

a. Pemeriksaan GDS (Gula Darah Sewaktu)

Yaitu tes gula darah yang dilakukan pada saat kapanpun walaupun sesudah makan. Hasilnya akan menggambarkan kadar gula darah. Jika hasil menunjukkan >200 mg/dl (11,1 mmol/L), maka sudah pasti orang tersebut menderita gula darah.

- b. Pemeriksaan GDP (Gula Darah Puasa),
Biasanya tes GDP dilakukan dengan sengaja dan untuk mengetahui kadar gula dalam darah setelah 8 sampai 10 jam tidak makan. Dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari. Nilai GDP tidak boleh lebih dari 126 mg/dl (> 7.0 mmol/L) karena akan terindikasi diabetes.
- c. Pemeriksaan Hemoglobin Glikat atau dikenal dengan nama (HbA1C)
Pemeriksaan ini bisa menguji produksi selama 3 bulan terakhir. Jika menunjukkan lebih dari 6,5 % maka bisa diidentifikasi dengan diabetes mellitus.
- d. Pemeriksaan TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral)
Walaupun berbeda tes, namun akurasinya sama. Tes ini mengharuskan untuk puasa terlebih dahulu dan 2 jam setelah minum, baru glukosa bisa diketahui. Jika nilai 2 jam setelah minum glukosa mencapai lebih besar atau sama dengan 200 mg/DL (11,1 mmol/L) maka seseorang terkena diabetes mellitus.

6. Komplikasi

Komplikasi diabetes mellitus bisa menyebabkan berbagai penyakit, dari yang paling ringan sampai parah. Penanganan medis harus segera dilakukan jika komplikasi berada pada kondisi yang parah. Diabetes merupakan penyakit yang dapat menyerang seluruh organ tubuh. Organ tubuh yang sering diserang antara lain jantung, mata, ginjal, pembuluh darah, gigi, hingga saraf. Penderita diabetes harus memiliki pola hidup yang sehat agar kadar gula dalam darah tetap normal. Komplikasi diabetes mellitus dapat memicu berbagai penyakit kronis yang berbahaya. Berikut adalah komplikasi diabetes melitus yang harus di ketahui.

a. Penyakit kardiovaskular

Menderita penyakit diabetes mellitus akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskuler tersebut antara lain stroke, serangan jantung dan penyempitan pembuluh darah. Tingginya kadar glukosa dalam tubuh akan membuat pengerasan pembuluh darah arteri lebih cepat dan akhirnya menghambat sirkulasi darah. Dalam website resminya, *American Heart Association* menjelaskan bahwa penderita diabetes melitus lebih mungkin meninggal karena komplikasi penyakit kardiovaskular yang dialami.

b. Penyakit ginjal

Dilansir dari Mayo clinic, sebagian orang yang mengalami diabetes melitus berisiko untuk mengalami kerusakan pada organ ginjal. Rusaknya ginjal akibat pada diabetes melitus dikenal dengan istilah medis nefropati diabetik. Kondisi nefropati diabetik terjadi akibat kadar gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah atau zat sisa pada tubuh. Jika kondisi tersebut dibiarkan dan tidak segera ditangani dengan segera. Maka dapat menyebabkan penyakit ginjal akut hingga gagal ginjal. Untuk mengeceknya, dokter akan mengambil sampel urin yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium.

c. Kerusakan saraf

Diabetes melitus dapat menyebabkan kerusakan saraf atau disebut neuropati diabetik. Kerusakan saraf yang ditimbulkan akibat diabetes ditandai dengan rasa nyeri, terasa kesemutan, kulit terasa terbakar, dan mati rasa. Kondisi tersebut terjadi ketika kadar gula darah

dalam tubuh sangat tinggi. Akibatnya, kondisi tersebut akan merusak saraf-saraf di dalam tubuh. Meski bisa terjadi dimanapun, kerusakan saraf akibat diabetes melitus biasanya lebih sering menyerang saraf di kaki. Untuk mengeceknya, dokter akan melakukan pemeriksaan elektromiografi untuk melihat kondisi saraf.

d. Kerusakan mata

Komplikasi berikutnya dari penyakit diabetes melitus adalah kerusakan pada organ mata. Istilah medisnya adalah retinopati diabetik. Penderita diabetes melitus sangat berisiko tinggi mengalami kerusakan mata jika diabetes melitus tidak segera ditangani. Kerusakan mata dimulai dengan penglihatan yang mulai kabur, terutama jika kadar gula darah sedang tinggi. Kondisi tersebut akan berlangsung lama dan biasanya kembali normal ketika kadar gula darah kembali normal. Beberapa kerusakan mata yang mungkin terjadi akibat diabetes melitus meliputi glaukoma, katarak diabetik, retinopati diabetik, edema diabetik.

e. Gastropati diabetik

Gastropati diabetik merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada saraf di lambung. Kondisi tersebut akhirnya membuat saraf otot lambung tidak dapat bekerja dengan baik dan menjadi lambat. Akibatnya, glukosa darah menjadi sulit untuk diatur sehingga sewaktu-waktu kadar gula darah bisa naik atau turun secara drastis. Pada kondisi ini, biasanya dokter akan menyarankan untuk mengatur pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi.

f. Disfungsi ereksi

Bagi seorang pria, menderita diabetes melitus dapat mengembangkan kemungkinan untuk mengalami disfungsi ereksi atau impotensi. Ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi terjadi akibat adanya kerusakan pada pembuluh darah dan saraf di penis.

g. Masalah kulit

Komplikasi diabetes melitus juga bisa membuat rentan mengalami masalah kulit. Tingginya kadar glukosa dalam darah menjadi tempat berkembang biak yang sangat baik bagi bakteri dan jamur. Akibatnya klien bisa mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal. Sebagian besar masalah kulit akibat diabetes melitus bisa dicegah dan berhasil diobati jika diketahui sejak dini.

h. Rentan mengalami infeksi

Diabetes melitus dapat memperlambat kemampuan tubuh untuk melawan infeksi bakteri dan virus. Ketika ini terjadi, bakteri yang menyerang akan tumbuh dan infeksi berkembang lebih cepat. Area yang umumnya diserang infeksi antara lain kandung kemih, ginjal, vagina, gusi, kaki, dan kulit.

i. Masalah gigi

Orang dengan diabetes berisiko tinggi menghadapi masalah kesehatan gigi dan mulut. Semakin tinggi kadar gula darah, maka semakin besar juga masalah kesehatan gigi dan mulut yang timbul. Hal ini terjadi ketika diabetes melitus tidak terkontrol dan kemudian merusak sel darah putih yang merupakan pertahanan utama tubuh dalam menghadapi infeksi di mulut. Seiring waktu akan menyebabkan plak dan plak yang

tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan gigi, penyakit gusi, periodontitis, serta kehilangan gigi.

j. Kaki diabetik

Diabetes melitus juga dapat menyerang saraf kaki atau biasa disebut kaki diabetik. Tingginya kadar gula darah akan merusak saraf dan jaringan di kaki. Akibatnya, ketika kaki mengalami luka. Penderita tidak menyadari adanya luka, karena kerusakan saraf yg terjadi (menjadi mati rasa) dan ketika kadar gula tidak stabil (tinggi) akan menghambat penyembuhan luka. Kebanyakan penderita diabetes melitus yang mengalami hal ini terpaksa harus merelakan kakinya untuk diamputasi jika kondisinya sudah parah.

B. Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2

Tatalaksana diabetes melitus tipe 2, meliputi tatalaksana diet, aktifitas fisik dan obat.

1. Tatalaksana Diet

Klien Diabetes Melitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat atau terapi insulin (Yasa Boga, 2011), yaitu:

a. Jadwal Makan

Klien dengan diabetes disarankan untuk makan teratur dengan jumlah (kalori) yang tepat. Interval antara waktu makan pada penderita diabetes adalah sekitar tiga jam. Karena itu, penderita diabetes bisa makan hingga enam kali sehari: yaitu tiga makanan utama dan tiga makanan ringan.

b. Jumlah Makanan

Jumlah makanan yang dikonsumsi per hari ditentukan oleh seberapa banyak energi yang dibutuhkan tubuh. Kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas sehari-hari dan keadaan atau kebutuhan khusus. Jumlah makanan untuk klien dengan diabetes melitus: Makan pagi 20%, snack I 10%, makan siang 30%, snack II 10%, makan malam 20%, snack III 10%. Pada prinsipnya, klien diabetes dapat mengonsumsi segala jenis makanan kaya energi, asalkan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dari total kalori per hari, penderita diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi jumlah kalori setiap kali makan sama dengan kebutuhan kalori sebagai berikut: Karbohidrat 50-60%, protein 10-15%, lemak < 30% sayur dan buah (vitamin dan mineral) secukupnya dan serat secukupnya.

c. Jenis Makanan

Pilih makanan dengan mempertimbangkan faktor indeks glikemik (GI), karena setiap jenis makanan memiliki indeks (efek langsung) pada kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik tinggi mudah dan cepat dipecah menjadi gula dan kemudian masuk ke aliran darah. Berikut makanan yang cocok untuk penderita diabetes, yaitu:

**Tabel 4.1. Indeks Glikemiks Bahan Makanan
Pada Klien Diabetes Melitus**

No	Jenis Bahan Makanan	Indeks Glikemik (%)	Keterangan
1	Karbohidrat ▪ Beras ketan ▪ Beras merah ▪ Kentang ▪ Singkong ▪ Tepung terigu	86,06 70,20 40 – 67,71 94,46 67,25	▪ Indeks Glikemik rendah < 70 ▪ Indeks Glikemik sedang 70 – 90 ▪ Indeks Glikemik tinggi > 90
2	Sumber Protein ▪ Kacang tanah ▪ Kacang kedelai ▪ Kacang hijau ▪ Kacang merah	-7,90 – 8,46 -17,53 28,87 4,34 – 9,46	
3	Buah – Buahan ▪ Pisang raja ▪ Pepaya ▪ Sawo ▪ Nangka ▪ Nanas	57,10 37 43,86 63,97 61,61	

2. Tatalaksana Aktifitas Fisik

Selain memperhatikan asupan makanan, aktivitas fisik seperti berolahraga, merupakan salah satu cara menjaga gula darah yang tepat pada penderita diabetes. Penderita diabetes tipe 2 sangat rawan mengalami obesitas, sehingga olah raga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan berat badannya. Olah raga juga menjadi bagian penting dalam pola hidup sehat diabetesi, selain membantu mengendalikan gula darah, berolahraga

juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi darah, membakar kalori untuk membantu kontrol berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, dan mencegah jatuh di usia lanjut.

a. Ketentuan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) durasi aktifitas fisik klien diabetes mellitus, yaitu minimal 150 menit per minggu, dikombinasi dengan minimal 2 kali latihan beban per minggu. Jika melakukan 3 kali seminggu, maka durasinya 50 menit per hari, dan jika 5 kali seminggu, maka durasinya 30 menit per hari.

Berikut tips menjaga kadar gula darah saat olahraga untuk diabetesi, yaitu:

1) Selalu cek kadar gula darah

Sebelum dan sesudah berolahraga, pastikan untuk memeriksa kadar gula darah sebelum aktif secara fisik.

a) Jika kadarnya berada di bawah 100 mg/dL, maka perlu makan camilan mengandung 15-30 gram karbohidrat, seperti: 2 sendok makan kismis, 1/2 cangkir jus buah atau soda biasa (bukan diet), tablet glukosa agar gula darah tidak turun terlalu rendah saat aktif secara fisik.

b) Jika di atas 240 mg/dL, gula darah mungkin terlalu tinggi (hiperglikemia) untuk bisa melakukan aktivitas fisik dengan aman.

2) Lakukan pengujian urin

Pengujian urin untuk keton/zat yang dibuat ketika tubuh memecah lemak untuk energi. Kehadiran keton menunjukkan bahwa tubuh tidak memiliki cukup insulin untuk mengontrol gula darah. Jika

aktif secara fisik ketika memiliki tingkat keton yang tinggi, berisiko terjadi ketoasidosis (komplikasi diabetes serius) yang membutuhkan perawatan segera.

3) Menyiapkan camilan dan air minum.

Jika memiliki penyakit DM dan hendak olahraga, pastikan untuk minum air yang cukup. Klien DM butuh banyak cairan dalam tubuh guna terhindar dari dehidrasi dan membantu ginjal agar tidak bekerja terlalu keras. Ada baiknya minum satu botol air ukuran 500 ml sebelum berolahraga, lalu minum sekitar 1/3 gelas air setiap 15 menit selama beraktivitas fisik dan/atau berolahraga. Selain air minum, mempersiapkan camilan saat olah raga sangat penting untuk menaikkan gula darah jika di tengah olahraga kadarnya menurun drastis, seperti jeruk, apel, dan kacang almond.

4) Beri tahu rekan dan pelatih tentang kondisi klien.

Usahakan untuk berolahraga bersama rekan-rekan terdekat dan pastikan mereka tahu kondisi anda. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi bisa mengantisipasi dan bisa meminta pertolongan. Selain itu, cara ini juga dilakukan agar pelatih atau *personal trainer* juga tahu hal-hal yang perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah berolahraga.

5) Kendalikan diri.

Agar Klien DM dapat berolahraga dengan aman, berolahragalah sesuai kemampuan dan kondisi fisik masing-masing. Kenali kapasitas diri dan mulai secara perlahan. Ada baiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program olah raga untuk

memastikan jenis dan intensitas olahraga yang sesuai dengan kondisi. Hindari olah raga yang terlalu berat. Jika tidak dapat berbicara saat berolahraga, berarti bahwa intensitas olah raga sudah terlalu berat dan perlu diturunkan.

6) Kosultasi

Sebelum memulai olahraga, sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau tenaga kesehatan profesional agar klien dapat mengetahui kapasitas tubuh, memilih olahraga yang tepat, dan mendapatkan tips lain yang bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan selama berolahraga.

b. Jenis Olah Raga

Berikut ini ada beberapa jenis olahraga untuk penderita diabetes:

1) Arobik.

Aerobik intensitas sedang yang dilakukan selama total 150 menit per minggu. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan mencoba memulai aerobik setidaknya 20 hingga 25 menit setiap hari.

2) Jalan cepat.

Jalan cepat merupakan bentuk latihan aerobik yang berguna meningkatkan denyut jantung, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Olahraga ini merupakan salah satu aktivitas yang bisa diatur intensitasnya sesuai dengan kemampuan fisik dan kondisi kesehatan diabetesi. Jika kondisi fisik cukup kuat, bisa mencoba berjalan kaki sambil menanjak atau *hiking*.

3) Senam diabetes.

Senam memfokuskan penyesuaian gerakan fisik dengan irama yang diperdengarkan. Senam diabetes dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, sehingga meningkatkan metabolisme dalam tubuh dan membantu penyerapan hormon insulin. Gerakan senam diabetes tidak berbeda dengan senam kebanyakan. Setiap gerakannya bertujuan untuk meregangkan, sekaligus merilekskan otot dan sendi. Gerakan senam diabetes antara lain:

- a) Latihan pemanasan dengan terlebih dulu merentangkan kedua tangan hingga sejajar bahu ke depan dan ke samping secara bergantian. Ulangi sampai tubuh terasa hangat dan siap masuk ke gerakan inti.
- b) Posisi tubuh berdiri tegap, langkahkan kaki tangan ke depan dengan kaki kiri diam di tempat.
- c) Angkat tangan kanan hingga sejajar dengan bahu dan tangan kiri menekuk ke arah dada. Ulangi gerakan ini pada tangan kiri. Lakukan bergantian selama beberapa kali.
- d) Gerakan pendinginan dengan melemaskan kedua kaki. Tekuk kaki kiri ke depan sambil memosisikan kaki kanan tetap lurus. Ulangi gerakan ini sebaliknya pada kaki yang lain.

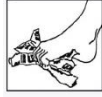
4) Senam kaki diabetes.

Senam kaki bisa dilakukan saat berdiri, duduk, berbaring, ataupun saat bersantai, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Langkah Gerakan Senam Kaki Diabetes

Langkah Gerakan Senam Kaki	
	Pasien duduk tegak di atas bangku dengan kaki menyentuh lantai.
	Latihan 1 (10 kali) 1. Tumit diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam 2. Luruskan kembali
	Latihan 2 (10 kali) 1. Tumit diletakkan di lantai, angkat telapak kaki ke atas. 2. Sebaliknya kaki lainnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai dan tumit kaki diangkat ke atas.
	Latihan 3 (10 kali) 1. Tumit diletakkan di lantai, bagian ujung jari kaki diangkat ke atas 2. Buat gerakan memutar kesamping pada pergelangan kaki 3. Turunkan kembali ke lantai dan buat gerakan ke arah tengah

	Latihan 4 (10 kali) 1. Jari-jari kaki diletakkan di lantai, tumit diangkat 2. buat gerakan memutar kesamping dengan pergerakkan pada pergelangan kaki 3. Turunkan kembali ke lantai dan buat gerakan ke arah tengah
	Latihan 5 (masing-masing kaki 10 kali) 1. Angkat salah satu lutut kaki, dan luruskan. 2. Gerakan jari-jari kaki kedepan kemudian turunkan kembali secara
	Latihan 6 (masing-masing kaki 10 kali) 1. Luruskan salah satu kaki diatas lantai kemudian angkat kaki tersebut 2. Gerakkan ujung jari-jari kaki ke arah wajah lalu turunkan kembali ke lantai.
	Latihan 7 (10 kali) 1. Angkat kedua kaki lalu luruskan dan pertahankan posisi tersebut 2. Gerakan kaki pada pergelangan kaki ke depan dan ke belakang secara bersamaan.
	Latihan 8 (masing-masing kaki 10 kali) 1. Luruskan salah satu kaki dan angkat 2. Putar kaki pada pergelangan kaki 3. lakukan gerakan seperti menulis di udara dengan kaki dari angka 0 hingga 10



Latihan 9 (1 kali)

1. Letakkan selembat koran dilantai, kemudian bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua belah kaki. Lalu buka kembali bola tersebut menjadi lembaran seperti semula menggunakan kedua belah kaki.
2. Kemudian robek koran menjadi 2 bagian, lalu pisahkan kedua bagian koran tersebut.
3. Sebagian koran di sobek-sobek menjadi kecil-kecil dengan kedua kaki.
4. Kemudian pindahkan kumpulan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki, lalu letakkan sobekan kertas pada bagian kertas yang utuh tadi.
5. Lalu bungkus semua sobekan-sobekan tadi dengan kedua kaki kanan dan kiri menjadi bentuk bola.

5) Yoga

Yoga menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Hal ini karena yoga adalah salah satu olahraga yang dapat membantu mengelola stres. Diabetesi juga bisa melakukan latihan yoga kapanpun sesuai dengan kondisi kesehatannya, dan tetap mengikuti arahan dari tenaga ahli atau profesional.

6) Bersepeda

Bersepeda merupakan bentuk latihan yang dapat membantu menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru. Selain itu, olahraga ini juga meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan diabetesi. Untuk

menghindari terjatuh dan cedera atau cuaca yang tidak mendukung, olahraga bersepeda bisa juga dilakukan menggunakan pelindung saat bersepeda.

7) Berenang

Berenang sangat bagus untuk diabetesi karena dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan membantu mengelola kadar gula darah. Selain itu, aktivitas fisik ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan dapat berkontribusi pada penurunan berat badan atau mempertahankan berat badan yang sehat. Berenang juga bermanfaat melatih pernapasan. Lewat olahraga ini, diabetesi bisa meningkatkan kapasitas paru-paru serta latihan mengontrol pernapasan. Selain untuk pernapasan, renang juga bermanfaat bagi diabetesi yang mengalami gejala diabetes seperti kesemutan atau mati rasa pada bagian kaki. Begitu pun dengan yang mengalami komplikasi gangguan saraf akibat penyakit diabetes yang ditandai dengan kesemutan, nyeri, atau mati rasa. Renang juga bermanfaat membantu menurunkan tingkat stres dan menurunkan kadar kolesterol. Olahraga ini akan merangsang enzim yang membantu mengeluarkan kolesterol jahat (LDL) dari darah ke hati. Kemudian, kolesterol diubah menjadi empedu untuk proses pencernaan atau dikeluarkan dari tubuh.

8) Angkat beban

Selain jenis olahraga tadi, diabetesi juga dapat melakukan latihan angkat beban yang direkomendasikan. Manfaat utamanya untuk meningkatkan massa otot. Saat massa otot bertambah, diabetesi akan lebih mudah

mengendalikan gula darah. Latihan angkat beban dapat membantu tubuh untuk merespons insulin dengan lebih baik. Hasilnya, tubuh bisa memperbaiki penyerapan dan penggunaan gula darah secara lebih optimal. Saat melakukan angkat beban, pastikan mengatur beban sesuai dengan kesanggupan. Hal ini penting untuk mencegah cedera bila memakai beban yang terlalu berat.

3. Tatalaksana Obat

Perawatan obat dilakukan bersamaan dengan diet dan olah raga (gaya hidup sehat). Perawatan obat terdiri dari obat-obatan yang diberikan secara oral dan bentuk injeksi. Antidiabetik oral (OHD) dibagi menjadi lima kelompok: 1) memicu sekresi insulin oleh sulfonilurea dan glinida, 2) meningkatkan sensitivitas insulin terhadap metformin dan thiazolidinediones, 3) penghambat glukoneogenesis, 4) penghambat penyerapan glukosa, dan 5) penghambat glukosidase alfa IV. (Asosiasi Diabetes Amerika. 2020).

BAB 5

KEPATUHAN KLIEN DIABETES MELITUS TIPE 2

A. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan atau "*compliance*", "*adherence*" dan "*concordance*" adalah istilah yang menggambarkan perilaku pasien dalam menelan obat dengan benar sesuai dosis, frekuensi, dan waktu. Kepatuhan dalam konteks psikologis mengacu pada situasi di mana perilaku seseorang mengikuti anjuran dokter atau informasi yang diperoleh dari sumber lain dalam bentuk pamflet atau melalui kampanye media massa (Ian dan Marcus, 2011).

Menurut WHO dan Perkeni, 2021, salah satu penentu keberhasilan penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2, yaitu kepatuhan klien terhadap diet, pengobatan dan aktifitas. Ketidakpatuhan klien menyebabkan munculnya komplikasi dan/atau kematian. Konsekuensi ketidakpatuhan berobat dalam jangka waktu panjang dapat memburuknya kondisi kesehatan dan meningkatkan biaya perawatan. Kepatuhan sangat penting bagi pasien dengan penyakit kronis, termasuk diabetes melitus.

B. Manfaat Perilaku Patuh

Perilaku patuh pada klien dengan diabetes mellitus Tipe 2 memiliki manfaat yang signifikan dalam pengelolaan kondisi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup,

mencegah komplikasi, dan memperbaiki kontrol glikemik. (Perkeni , 2021, CDC, 2023)

1. Pengendalian Gula Darah yang Lebih Baik

Patuh terhadap anjuran medis, seperti diet sehat, aktivitas fisik, dan minum obat secara teratur, membantu menstabilkan kadar gula darah. Pengendalian yang baik mengurangi risiko komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan pembuluh darah dan saraf. Ketika klien tidak patuh, fluktuasi glukosa darah dapat terjadi, yang mengakibatkan efek buruk pada tubuh dalam jangka panjang. Dengan menjaga kepatuhan pada terapi dan gaya hidup sehat, klien dapat mengontrol kadar glukosa darah secara konsisten. Perbaikan kontrol glikemik tidak hanya membantu mencegah komplikasi tetapi juga membantu tubuh lebih adaptif terhadap diabetes, sehingga gejala seperti kelelahan, sering buang air kecil, atau luka yang sulit sembuh menjadi berkurang. Kontrol glikemik yang baik juga berkaitan erat dengan perasaan sehat secara keseluruhan.

2. Mengurangi Risiko Komplikasi.

Diabetes Melitus Tipe 2 berisiko tinggi mengalami komplikasi jangka panjang, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, neuropati (kerusakan saraf), retinopati (gangguan penglihatan), dan gangguan peredaran darah. Komplikasi ini timbul terutama akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol. Kepatuhan dalam mengonsumsi obat, melakukan pemeriksaan rutin, menjaga pola makan, dan berolahraga sangat penting untuk mencegah atau memperlambat komplikasi tersebut. Dengan pengendalian yang baik, risiko komplikasi dapat dikurangi, sehingga pasien dapat hidup lebih lama dan sehat tanpa gangguan besar dari komplikasi.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Kualitas hidup pasien.

Diabetes Melitus Tipe 2 sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola kondisi tersebut sehari-hari. Ketika pasien mematuhi jadwal obat, pola makan yang seimbang, dan rutinitas aktivitas fisik, mereka cenderung memiliki gejala yang lebih terkendali, seperti mengurangi rasa lelah, haus berlebihan, atau penurunan berat badan yang tidak terkontrol. Dengan kepatuhan, pasien dapat menjaga kadar glukosa darah dalam batas normal, yang dapat mengurangi efek samping penyakit dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental. Pada akhirnya, pasien yang patuh akan lebih mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan produktif.

4. Memperlambat Progresivitas Penyakit

Kepatuhan dapat memperlambat perkembangan Diabetes Melitus Tipe 2 sehingga membantu pasien menjaga kondisi kesehatannya lebih baik dalam jangka panjang.

5. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Kesehatan

Ketika pasien patuh, mereka lebih mungkin mengikuti arahan profesional kesehatan, seperti pola makan yang sehat, pentingnya aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ini meningkatkan pemahaman mereka terhadap kondisi dan peran mereka dalam manajemen kesehatan.

C. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dan Ketidapatuhan

Penatalaksanaan Diabetes Melitus cenderung seumur hidup, meliputi penatalaksanaan faktor risiko, penatalaksanaan aktivitas, diet dan pengobatan sehingga pasien sering mengalami kejenuhan dan kelalaian dalam

penatalaksanaan perawatan. Penelitian Husnah, Zufry dan Maisura (2014) menunjukkan bahwa 49,5% klien tidak menyelesaikan terapi obat, 39,6% melanggar pelaksanaan terapi diet dan 35,2% enggan melakukan terapi olah raga. Dalam penatalaksanaan diabetes melitus, terdapat empat pilar yang harus diikuti oleh penderita diabetes, yaitu pengetahuan, kepatuhan diet, aktivitas fisik dan kepatuhan minum obat (FK-UI, 2018).

1. Faktor Kepatuhan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan klien dengan diabetes melitus tipe 2:

a. Pengetahuan dan Pemahaman

Klien yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang Diabetes Melitus tipe 2, serta manfaat pengobatan dan risiko komplikasi, cenderung lebih patuh terhadap pengobatan. (Misbach & Mohamed, 2015)

b. Dukungan Sosial dan Keluarga

Dukungan dari keluarga atau teman membantu klien mengelola penyakit dengan lebih baik, meningkatkan kepatuhan dalam jangka panjang. (Karimy et al., 2018). Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan seseorang, dan juga dapat menentukan keyakinan dan nilai kesehatan seseorang.

c. Motivasi dan Sikap

Motivasi intrinsik untuk hidup sehat dan sikap positif terhadap pengobatan mendorong kepatuhan terhadap pengobatan Diabetes Melitus. (Jahangiry et al., 2017)

d. Komunikasi

Komunikasi antar klien dan tenaga kesehatan membantu klien memahami pentingnya penata

laksanaan diabetes dan mematuhi intruksi. Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan klien merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. (Bogner et al., 2015). Klien membutuhkan penjelasan tentang diagnosis mereka saat ini, apa penyebabnya, dan apa yang dapat mereka lakukan. (Feuerstein et al., 2019)

2. Faktor Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan pasien dapat menyebabkan kekambuhan dan/atau komplikasi, termasuk makroangiopati, mikroangiopati, neuropati diabetik, dan kaki diabetik. Dalam jangka panjang, akibat ketidakpatuhan dapat memperburuk kesehatan dan meningkatkan biaya pengobatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan klien Diabetes Melitus Tipe 2, adalah:

- a. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Penyakit
Pengetahuan yang kurang tentang diabetes, komplikasi, dan pentingnya pengelolaan yang konsisten dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Vijan, S., & Hayward, R. A. (2003).
- b. Kompleksitas dan Efek Samping Pengobatan
Banyak pasien merasa terbebani dengan jadwal pengobatan yang rumit atau mengalami efek samping yang membuat mereka enggan untuk melanjutkan pengobatan. Ho, P. M., Bryson, C. L., & Rumsfeld, J. S. (2009).
- c. Dukungan Sosial
Pasien dengan dukungan sosial yang rendah, baik dari keluarga atau teman, sering kali merasa kesulitan untuk mematuhi rutinitas pengobatan. Gallant, M. P. (2003).

d. Faktor Psikologis

Kondisi seperti depresi atau kecemasan dapat mengurangi motivasi pasien dalam mematuhi pengobatan. Gonzalez, J. S., Peyrot, M., McCarl, L. A., et al. (2008).

e. Faktor Ekonomi

Ketidakmampuan finansial untuk membeli obat atau akses ke perawatan medis yang mahal sering menjadi penghalang kepatuhan. Piette, J. D., Heisler, M., & Wagner, T. H. (2004).

f. Budaya dan Keyakinan

Budaya atau keyakinan tertentu mungkin memengaruhi persepsi tentang penyakit dan pengobatan yang dianjurkan. Bandyopadhyay, S., Bayer, A. J., & O'Mahony, M. S. (2001).

g. Kepuasan Terhadap Layanan Kesehatan

Klien yang merasa kurang puas dengan layanan atau hubungan dengan tenaga medis cenderung kurang patuh terhadap pengobatan. DiMatteo, M. R., Giordani, P. J., Lepper, H. S., et al. (2002).

D. Pengukuran Kepatuhan

Pengukuran Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe-2 menggunakan instrumen yang sudah baku, sebagai berikut:

1. Pengukuran Kepatuhan Klien pada Diet

Intrumen untuk pengukuran kepatuhan diit meliputi data kepatuhan diet dengan menggunakan kuesioner *Perseived Dietary Adherence Questionnaire/PDAQ* (Assad, 2015) dengan sembilan pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki penilaian kemungkinan jawaban dari nilai 1 sampai 7, total nilai tertinggi 63 dan terendah 9.

Tabel 5.1. Kuesioner Kepatuhan Diet PDAQ

No	Pertanyaan	Jawaban						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Berapa kali anda makan tepat waktu sesuai jadual yang sudah dikonsultasikan dengan dokter/ tenga kesehatan lain ?							
2	Berapa kali anda makan lebih dari 3 kali / hari dalam seminggu terakhir ?							
3	Berapa kali anda makan buah dan sayuran yang mengandung vitamin sesuai porsi yang dianjurkan dalam seminggu terakhir ?							
4	Karena kesibukan anda, berapa kali anda makan tidak tepat waktu dalam seminggu terakhir ?							
5	Berapa kali anda makan makanan yang banyak mengandung minyak/lemak tinggi seperti makanan siap saji, gorengan, usus dan hati dalam seminggu terakhir ?							
6	Berapa kali anda gula pengganti seperti gula jagung pada saat anda ingin mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis ?							
7	Berapa kali anda makan makanan tinggi gula seperti kue, kue kering, buah dengan kadar gula tinggi (pisang,							

	anggur, mangga), permen, dll dalam seminggu terakhir ?						
8	Berapa kali anda makan makanan camilan yang asin dalam seminggu terakhir ?						
9	Berapa kali anda makan makanan yang mengandung protein seperti telur sesuai anjuran dokter/tenaga kesehatan lain dalam seminggu terakhir ?						

2. Pengukuran Kepatuhan Klien pada Latihan Akrifitas Fisik

Intrumen untuk pengukuran kepatuhan aktifitas fisik meliputi data kepatuhan aktifitas fisik klien Diabetes Melitus dengan menggunakan kuesioner dari PERKENI (2015) dengan sebelas pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki penilaian kemungkinan jawaban Ya (nilai 1) dan Tidak (nilai 0), total nilai tertinggi 11 dan terendah 0.

Tabel 5.2 Kuesioner Kepatuhan Aktifitas Fisik

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda rutin berolah raga setiap minggu ?		
2	Apakah anda melakukan OR seperti jalan atau bersepeda sampai atau jogging atau berenang dalam seminggu ?		
3	Apakah anda melakukan OR 3 -5 kali dalam seminggu ?		
4	Apakah anda setiap melakukan OR menghabiskan waktu 30 - 45 menit ?		

5	Setelah selesai makan, anda terbiasa langsung tidur ?		
6	Setiap keluar rumah, anda selalu menggunakan alas kaki (sandal atau sepatu)		
7	Saya membawa permen atau jelly di setiap kegiatan saya		
8	Saya lebih memilih berjalan kaki ketika saya pergi ke tempat yang dekat dari rumah (pasar, rumah teman, tempat ibadat)		
9	Ketika saya mempunyai waktu luang, saya gunakan untuk nonton TV di rumah dari pada berolah raga		
10	Saya lebih suka menggunakan tangga dari pada lift, karena saya anggap berolah raga		
11	Saya ber OR dimulai dengan gerakan lambat, lalu ditingkatkan kecepatannya		

3. Pengukuran Kepatuhan Klien pada Obat

Instrumen untuk pengukuran kepatuhan minum obat meliputi data kepatuhan klien Diabetes Melitus dengan menggunakan *Morisky Medication Adherence Scale* 8 item (MMAS-8) dengan delapan pertanyaan. MMAS-8 adalah suatu alat ukur yang dikembangkan oleh Morisky, dkk untuk menilai kepatuhan minum obat.

Pengukuran skor MMAS-8: 1) Pertanyaan 1 - 7 jika jawabannya Ya, bernilai 0 dan jawaban Tidak, bernilai 1, 2) Pertanyaan nomer 5 jika jawaban Ya bernilai 1 dan jawaban Tidak bernilai 0, 3) Pertanyaan nomer 8 jika jawaban: tidak pernah/jarang (tidak sekalipun dalam seminggu) bernilai 4, jika menjawab sekali-kali (satu/dua kali dalam seminggu) bernilai 3, terkadang (tiga/empat

kali dalam seminggu) bernilai 2, biasanya (lima/enam kali seminggu) bernilai 1 dan selalu/setiap saat bernilai 0.

Tabel 5.3 Kuesioner Kepatuhan Obat MMAS-8

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda kesulitan mengingat jadwal/waktu minum obat ?		
2	Saya kadang lupa untuk minum obat tepat waktu		
3	Dalam 2 minggu terakhir beberapa kali saya tidak minum obat karena lupa		
4	Ketika bepergian (meninggalkan rumah), apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat ?		
5	Ketika uncul efek samping obat yang tidak mengenakan, apakah anda berhenti meminum obat tanpa memberi tahu dokter ?		
6	Bila anda merasa kondisi tubuh baik, apakah anda kadang berhenti minum obat ?		
7	Apakah anda merasa tersiksa dengan harus meninum obat setiap hari ?		
8	Apakah anda sulit untuk mematuhi anjuran dokter untuk rutin meminum obat ?		
9	Ketika mengkonsumsi obat DM, saya mengkonsumsi obat tersebut sebelum makan (sesuai anjuran dr)		
10	Apakah anda sering sulit mengingat untuk meminum semua obat anda ?		

BAB 6

PENUTUP

Terapi perilaku ABC merupakan gabungan dari tiga unsur, yaitu: *antecedents*, *behaviour* dan *consequences*. Model terapi perilaku ABC menjelaskan bahwa perilaku sebenarnya dapat diubah dengan mempengaruhi perilaku sebelum terjadi dan mempengaruhi perilaku sesudahnya. Upaya untuk mempengaruhi perilaku sebelum itu terjadi, berarti telah menggunakan *antecedents*, dan upaya mempengaruhi perilaku dengan melakukan sesuatu setelah perilaku itu terjadi, berarti telah menggunakan *consequences*. Jadi *antecedens* mendorong terbentuknya tingkah laku (behavior) yang diikuti dengan akibat. Memahami ketiga elemen yang saling berinteraksi ini sangat berguna dalam menganalisis masalah perilaku, menentukan tindakan korektif, dan merancang lingkungan dan sistem manajemen perilaku tinggi (Mayer, 1977).

Antecedents dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, sesuatu, atau kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. *Antecedents* ini keberadaanya tidak dapat dikendalikan. Karakteristik utama dari *antecedents* adalah sebagai berikut: 1) Selalu ada sebelum perilaku terbentuk, 2) Menyediakan informasi tertentu, 3) Selalu berpasangan dengan *consequences*, 4) *Consequences* yang muncul bisa jadi merupakan antecedents, dan 5) *Antecedents* tanpa diikuti *consequences* mempunyai dampak jangka pendek. *Antecedents* pada klien Diabetes Melitus, antara lain: Obesitas

atau kelebihan berat badan, adanya lemak yang menumpuk pada perut, sedentari atau kurang aktif bergerak, Usia terutama di atas 45 tahun, riwayat keluarga dekat yang pernah mengidap diabetes tipe 2 sebelumnya, riwayat diabetes gestasional, dan diet/gizi tidak seimbang. *Antecedents* ini mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi tidak menjamin bahwa output yang dihasilkan benar-benar bisa terjadi. Pendidikan kesehatan efektif untuk mengubah perilaku, meliputi pemahaman tentang penyakit Diabetes Melitus dan tatalaksana Diabetes Melitus baik terkait diet, aktifitas fisik maupun penggunaan obat.

Perilaku (*Behaviour*) merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas. Teori motivasi menjelaskan bagaimana seseorang dapat dipengaruhi untuk bisa menyesuaikan diri pada perilaku yang baru. Dalam hal ini terjadi proses penyesuaian diri pada perilaku baru yang dibentuk, dan terjadi proses pembelajaran tentang perilaku mana yang sukses dan gagal serta upaya membantu klien diabetes melitus tipe 2 menyesuaikan diri. *Consequences* adalah peristiwa yang mengikuti suatu perilaku dan mengubah kemungkinan bahwa perilaku itu akan diulangi di masa depan. *Consequences* mempengaruhi perilaku dengan dua cara, yaitu dengan memperkuat perilaku dan dengan mengurangi perilaku tertentu. Ada empat *consequences* perilaku: dua meningkatkan perilaku tertentu dan dua menurunkannya. *Consequences* yang memperkuat perilaku tertentu klien diabetes melitus tipe 2, yaitu penguatan positif, seperti semakin tingginya kadar gula darah, terhindar dari komplikasi atau memperburuknya keadaan, dan penguatan negatif, seperti meninggalkan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti makan sembarangan, tidak beraktifitas yang baik serta tidak sembarangan minum obat, bahkan sampai ke finalinya, yakni munculnya komplikasi dan kematian.

Perilaku ABC (*antecedents, behaviour* dan *consequences*) penting untuk meningkatkan kepatuhan klien diabetes mellitus tipe 2 baik kepatuhan terhadap diet, kepatuhan terhadap aktifitas fisik maupun kepatuhan terhadap obat. (Supriadi & Kulsan S, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children: A cross-sectional study in the public health center of Jember, Indonesia. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- American Diabetes Association (ADA), 2020, *Standards of Medical Care in Diabetes*. Diabetes Care.
- Alexander, S., Ostfeld, R. J., Allen, K., & Williams, K. A. (2017). A plant-based diet and hypertension. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 327–330. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.014>
- Aljuraiban, G., Chan, Q., Gibson, R., Stamler, J., Daviglus, M. L., Dyer, A. R., Miura, K., Wu, Y., Ueshima, H., Zhao, L., Van Horn, L., Elliott, P., & Oude Griep, L. M. (2020). Association between plant-based diets and blood pressure in the INTERMAP study. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(2), 133–142. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000077>
- Allender, J. A., & Spardley, B. W. (2011). *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Anderson, E., & McFarlane, J. (2004). *Community As Partner: Theory and Practice in Nursing* (4th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.
- Aristi, D. L. A., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., &

- Siswoyo, S. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 53–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2741>
- Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>
- Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). "Adult Obesity Causes & Consequences." [CDC Website] (<https://www.cdc.gov/obesity/adult/causes.html>).
- Diabetes Care (2020), *Global Changes in Diet and Diabetes Risk*.
- Gupta, A. K., Mongia, M., & Garg, A. K. G. (2018). *A descriptive study of behavioral problems in schoolgoing children*. *Industrial Psychiatry Journal*, 195–201. <https://doi.org/10.4103/ipj.ipj>
- Halder, S., & Kejriwal, S. (2016). *Nutritional awareness of mothers in relation to nutritional status of the preschool children*. *Early Child Development and*

Care, 186(9), 366–1377.

- Handayani, D., Kusuma, E., Puspitasari, H., & Nastiti, A. D. (2022). *The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Coastal Areas*. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(3), 755–764.
<https://doi.org/10.30604/jika.v7i3.967>
- Harahap, R. A., Rochadi, R. K., & Sarumpae, S. (2018). *Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki Dewasa Awal (18-40 Tahun) Di Wilayah Puskesmas Bromo Medan*. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.951>
- Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). *Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease*. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368.
<https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>
- Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). *Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di kecamatan panti kabupaten jemmer*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.
- Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). *Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease*. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*, 29(1), 16–21.
<https://doi.org/10.1097/MNH.0000000000000574>

- Kavosi, E., Rostami, Z., Kavosi, Z., Nasihatkon, A., Moghadami, M., & Heidari, M. (2014). *Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province*. *Iran Int J Health Policy Manag*, 3(2), 71–76.
- Kemenkes RI. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga* (Vol. 21, Issue 1). Kementerian Kesehatan RI. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), 2021, *Genetics of Diabetes*.
- The Lancet, 2020, *Obesity and its Impact on Health: A Global Perspective*.
- Tremblay, M. S., et al. (2010). *"Physiological and health implications of a sedentary lifestyle."* *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(6), 725–740. <https://doi.org/10.1139/H10-019>.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Obesity and overweight*. [WHO Website] (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>).
- World Health Organization (WHO). (2020). *Physical Activity and Sedentary Behavior*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>.
- Zhang, Y., et al. (2018), *Age and Diabetes: A Population-Based Study*. *Diabetes Care*.

GLOSARIUM

ABC	: <i>Antecedents, Behaviour and Consequences</i>
ADA	: <i>American Diabetes Association</i>
CDC	: Centers for Disease Control
DM	: Diabetes Melitus
PDAC	: <i>Perseived Dietary Adherence Questionnaire</i>
GDS	: Gula Darah Sewaktu
GDP	: Gula Darah Puasa
MMAS-8	: <i>Morisky Medication Adherence Scale</i> 8 item
PTM	: Penyakit Tidak Menular
ICD	: <i>International Classification of Diseases</i>
IDF	: <i>International Diabetes Federation</i>
GI	: <i>Glikemic Indeks</i>
NIDDK	: <i>National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases</i>
TTGO	: Tes Toleransi Glukosa Oral
WHO	: <i>World Health Organization</i>

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep, Sp.Kom.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di PSIK FK Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di FIK Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan Doktoral Bidang Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Pengalaman mengajar dimulai sejak tahun 1988 dalam berbagai bidang keperawatan seperti Keperawatan Dasar, Falsafah dan Teori Keperawatan, Kebijakan Kesehatan dengan bidang utamanya Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Komunitas. Penulis juga aktif sebagai peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, penulis buku serta nara sumber terkait pengembangan keperawatan kesehatan masyarakat dan penjaminan mutu Pendidikan tinggi.

Penulis dapat dihubungi melalui email: supriadifalah@gmail.com

Pesan untuk pembaca: jadilah insan pembelajar yang penuh manfaat untuk orang banyak, tidak ada kata malas membaca untuk hidup

PROFIL PENULIS



Kuslan Sunandar, SKM., M.Kep., Sp.Kom.

Menyelesaikan Sekolah Guru Perawat di SGP Depkes Pajajaran Bandung, Akper Depkes Pajajaran Bandung plus Akta Mengajar III. Sarjana Kesehatan Masyarakat di FKM Universitas Indonesia. Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan

Komunitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pengalaman mengajar dimulai sejak tahun 1987 dalam bidang kesehatan dan keperawatan, seperti Ilmu Kesehatan Masyarakat, Nursing Art, Kebijakan Kesehatan, Antropologi Kesehatan, Promosi Kesehatan dengan mata kuliah utama yang diampu Keperawatan Keluarga, Keperawatan Geronti dan Keperawatan Komunitas. Penulis juga aktif pada kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: kuslan_sunandar@yahoo.com

Pesan untuk pembaca: Belajar sepanjang hayat untuk kemaslahatan umat dan lingkungan hidup.

SINOPSIS BUKU

Diabetes melitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang di Indonesia, sebagai salah satu penyebab kematian serta dapat menimbulkan komplikasi, sehingga penatalaksanaan diabetes melitus yang tepat diperlukan untuk mengurangi kejadian dan/atau resiko kematian dan komplikasi yang tidak diinginkan. Target klien diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pasien diabetes ditetapkan 100%, yang dilakukan di seluruh tingkat pelayanan, termasuk di komunitas. Kepatuhan klien diabetes melitus Tipe 2 dalam tatakelola diet, aktivitas fisik dan obat mutlak diperlukan untuk menurunkan kejadian, komplikasi dan/atau kematian akibat diabetes melitus.

Terapi perilaku ABC terdiri dari tiga unsur, yaitu *antecedents*, *behavior*, dan *consequences*. Model ini menjelaskan bahwa perilaku dapat diubah dengan mempengaruhi apa yang terjadi sebelum (*antecedents*) dan sesudahnya (*consequences*). *Antecedents* memicu perilaku tertentu, *behavior* adalah aktivitas yang diamati pada seseorang, dan *consequences* adalah hasil yang mengikuti perilaku dan menentukan apakah perilaku tersebut akan diulangi, baik melalui penguatan atau pengurangan. Model ini berguna untuk menganalisis masalah perilaku klien diabetes melitus tipe 2, merancang sistem manajemen, dan membantu klien diabetes mellitus tipe 2, menyesuaikan diri dengan perilaku baru melalui proses pembelajaran.

Buku Monograf Model Perubahan Perilaku ABC (*Antecedents Behaviour and Consequences*) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe 2 ini merupakan buku yang ditujukan untuk mahasiswa keperawatan/kesehatan, dosen dan praktisi dalam memberikan pelayanan pada klien diabetes melitus tipe 2 untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam tatakelola diet, tatakelola aktifitas fisik dan tatakelola obat, maka dalam buku ini diuraikan tentang konsep pendidikan kesehatan, konsep diabetes

melitus serta tatakelola diabetes melitus Tipe 2, terapi perilaku ABC, dan kepatuhan klien diabetes melitus Tipe 2.

Selain itu, buku yang ditulis oleh Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom dan Kuslan Sunandar, SKM, M.Kep, Sp.Kom ini juga memperhatikan perkembangan terbaru dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2, sehingga pembaca dapat mengikuti trend terkini dan *best practices* dalam bidang keperawatan. Dengan pendekatan perubahan perilaku, dan didukung pemberdayaan klien, buku ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan profesional perawat serta kemandirian klien diabetes melitus Tipe 2 untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan dan kualitas hidup klien diabetes melitus tipe 2.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan mahasiswa, dosen dan praktisi keperawatan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sehingga nantinya dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai perawat, baik di tatanan klinik maupun di tatanan komunitas, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup klien.

Diabetes melitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang di Indonesia, sebagai salah satu penyebab kematian serta dapat menimbulkan komplikasi, sehingga penatalaksanaan diabetes melitus yang tepat diperlukan untuk mengurangi kejadian dan/atau resiko kematian dan komplikasi yang tidak diinginkan. Target klien diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pasien diabetes ditetapkan 100%, yang dilakukan di seluruh tingkat pelayanan, termasuk di komunitas. Kepatuhan klien diabetes melitus Tipe 2 dalam tatakelola diet, aktivitas fisik dan obat mutlak diperlukan untuk menurunkan kejadian, komplikasi dan/atau kematian akibat diabetes melitus.

Terapi perilaku ABC terdiri dari tiga unsur, yaitu antecedents, behavior, dan consequences. Model ini menjelaskan bahwa perilaku dapat diubah dengan mempengaruhi apa yang terjadi sebelum (antecedents) dan sesudahnya (consequences). Antecedents memicu perilaku tertentu, behavior adalah aktivitas yang diamati pada seseorang, dan consequences adalah hasil yang mengikuti perilaku dan menentukan apakah perilaku tersebut akan diulangi, baik melalui penguatan atau pengurangan. Model ini berguna untuk menganalisis masalah perilaku klien diabetes melitus tipe 2, merancang sistem manajemen, dan membantu klien diabetes mellitus tipe 2, menyesuaikan diri dengan perilaku baru melalui proses pembelajaran.

Buku Monograf Model Perubahan Perilaku ABC (Antecedents Behaviour and Consequences) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Klien Diabetes Melitus Tipe 2 ini merupakan buku yang ditujukan untuk mahasiswa keperawatan/kesehatan, dosen dan praktisi dalam memberikan pelayanan pada klien diabetes melitus tipe 2 untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam tatakelola diet, tatakelola aktifitas fisik dan tatakelola obat, maka dalam buku ini diuraikan tentang konsep pendidikan kesehatan, konsep diabetes melitus serta tatakelola diabetes melitus Tipe 2, terapi perilaku ABC, dan kepatuhan klien diabetes melitus Tipe 2.

Selain itu, buku yang ditulis oleh Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom dan Kuslan Sunandar, SKM, M.Kep, Sp.Kom ini juga memperhatikan perkembangan terbaru dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2, sehingga pembaca dapat mengikuti trend terkini dan best practices dalam bidang keperawatan. Dengan pendekatan perubahan perilaku, dan didukung pemberdayaan klien, buku ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan profesional perawat serta kemandirian klien diabetes melitus Tipe 2 untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan dan kualitas hidup klien diabetes melitus tipe 2.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan mahasiswa, dosen dan praktisi keperawatan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sehingga nantinya dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai perawat, baik di tatanan klinik maupun di tatanan komunitas, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup klien.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

